Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Врач-оториноларинголог, специалист по хирургии головы и шеи

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ

Тимпанопластика

Восстановление барабанной перепонки (при необходимости — с восстановлением слуховых косточек и мастоидэктомией)

Уважаемый пациент, эта форма составлена для того, чтобы **простым и понятным языком** рассказать вам о том, что необходимо знать о рекомендованной вам процедуре. Её цель — не напугать вас, а помочь вам принять решение **свободно и на основе достоверной информации**.

Пожалуйста, прочитайте эту форму не торопясь. Обо всём, что вам непонятно, спросите своего врача. Врач также устно объяснит вам риски, связанные именно с вашим состоянием. Давать или не давать согласие — исключительно ваше право.

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ И ПРОЦЕДУРЕ

Фамилия, имя: _____ Дата рождения: _____

№ паспорта / удостоверения личности: _____ № карты / протокола: _____

Телефон: _____ Дата информирования: _____

Планируемая дата процедуры: _____

Форма впервые передана пациенту (дата / эл. почта, WhatsApp, лично): _____

Врач, который выполняет процедуру и предоставляет информацию: **Op. Dr. Murat Ayata**

Больница / медицинское учреждение, где будет выполнена процедура: _____

Сторона: ☐ Справа ☐ Слева

Визуализация: ☐ Микроскопическая ☐ Эндоскопическая ☐ Будет определено во время операции _____

Доступ: ☐ Трансканальный ☐ Заушный ☐ Эндауральный _____

Источник трансплантата: ☐ Фасция мышцы (фасция височной мышцы) ☐ Хрящ / надхрящница ☐ Другое _____

Восстановление слуховых косточек (оссикулопластика): ☐ Не планируется ☐ Планируется ☐ При необходимости _____

Мастоидэктомия: ☐ Не планируется ☐ Планируется ☐ При необходимости _____

Дата и краткие результаты предоперационного исследования слуха (аудиограммы): _____

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

1 Ваше состояние и цель процедуры

Барабанная перепонка — это тонкая мембрана, которая отделяет наружный слуховой проход от среднего уха и передаёт звуковые колебания крошечным косточкам (слуховым косточкам) среднего уха. При наличии в барабанной перепонке **отверстия (перфорации)** слух снижается, а попадание в ухо воды или микробов вызывает **повторяющиеся выделения из уха**.

Перфорации барабанной перепонки чаще всего возникают вследствие **хронического воспаления среднего уха**, а иногда — травмы (пощёчина, ватная палочка, резкий перепад давления). Небольшие недавно образовавшиеся отверстия могут закрыться самостоятельно; однако давно существующие отверстия обычно не закрываются. У некоторых пациентов воспаление может также разрушить слуховые косточки среднего уха или распространиться на воздухоносные ячейки кости за ухом (сосцевидного отростка). Если в среднем ухе имеется **холестеатома** (мешочек из клеток кожи, который растёт и разрушает кость), её лечение особенно важно.

Цель тимпанопластики — закрыть отверстие в барабанной перепонке, очистить среднее ухо от воспаления, чтобы получить **сухое и безопасное ухо**, и по возможности **сохранить или улучшить слух**.

2 Как выполняется процедура?

Операция проводится в операционной под общим наркозом с использованием микроскопа и/или эндоскопа.

1. **Доступ:** Если отверстие небольшое и удобно расположено, операцию можно выполнить полностью через слуховой проход, и снаружи не останется рубца. При более крупных отверстиях или когда необходим более широкий обзор делается небольшой разрез за ухом (в складке позади ушной раковины) или перед ухом.
2. **Забор трансплантата:** Для восстановления барабанной перепонки используются собственные ткани пациента: обычно фасция мышцы, расположенной над ухом (фасция височной мышцы), или хрящ ушной раковины с его оболочкой (надхрящницей). Эти ткани берутся через тот же разрез или через небольшой дополнительный разрез.
3. **Очищение среднего уха:** Края отверстия освежаются, барабанная перепонка приподнимается и осматривается среднее ухо; при наличии удаляются воспалённые ткани и спайки. Проверяется состояние слуховых косточек.
4. **Восстановление слуховых косточек (при необходимости):** Если цепь слуховых косточек разрушена или разорвана, её можно восстановить с помощью собственной косточки/хряща пациента или биосовместимого протеза, например титанового.
5. **Мастоидэктомия (при необходимости):** Если воспаление или холестеатома распространились на воздухоносные ячейки кости за ухом, эти ячейки вскрываются и очищаются с помощью специального бора.
6. **Установка трансплантата и ушивание:** Трансплантат помещается под отверстие или поверх него. Среднее ухо и слуховой проход поддерживаются рассасывающимися губками. Разрез, если он был, ушивается, и на ухо накладывается давящая повязка.

При обнаружении холестеатомы у некоторых пациентов может быть запланирована **повторная контрольная операция («second look») через 6–12 месяцев**, чтобы убедиться, что заболевание полностью удалено. Это будет объяснено вам отдельно.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИМЕРНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	ПРЕБЫВАНИЕ В БОЛЬНИЦЕ / ВЫПИСКА
Общий наркоз	Около 1,5–3 часов (дольше при мастоидэктомии)	Обычно выписка в тот же день или через 1 ночь

3 Ожидаемая польза и вероятность успеха

- Закрытие отверстия в барабанной перепонке
- Уменьшение или прекращение эпизодов выделений из уха и воспалений; сухое и безопасное ухо

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Меньше ограничений, необходимых для защиты уха при купании, приёме душа и плавании
- Сохранение или улучшение слуха у подходящих пациентов
- При наличии холестеатомы — удаление заболевания и предотвращение его возможных серьёзных осложнений

Стойкое закрытие барабанной перепонки достигается примерно у **85–95%** пациентов. Улучшение слуха зависит от состояния слуховых косточек, распространённости воспаления и состояния внутреннего уха; слух может значительно улучшиться, остаться прежним или в редких случаях ухудшиться. Если трансплантат не приживётся или образуется новое отверстие, операцию можно повторить.

4 Другие варианты лечения

- **Наблюдение и поддержание уха сухим:** При небольших сухих отверстиях возможны регулярные осмотры и защита уха от воды. Отверстие остаётся открытым, и риск воспаления сохраняется.
- **Медикаментозное лечение:** Ушные капли с антибиотиком временно подавляют воспаление в периоды выделений; отверстие они не закрывают.
- **Слуховой аппарат:** Может компенсировать снижение слуха; однако при выделениях из уха пользоваться им может быть трудно, и отверстие он не закрывает.
- **Простое закрытие небольших отверстий:** При очень маленьких отверстиях может рассматриваться закрытие бумажной заплаткой или жировой тканью (миринготластика).

5 Что будет, если процедуру не проводить?

Без операции отверстие в барабанной перепонке обычно остаётся открытым. Выделения могут повторяться при попадании воды в ухо или при простудных заболеваниях, а снижение слуха со временем может усиливаться. Если имеется холестеатома и её не лечить, она продолжает расти и может привести к серьёзным осложнениям, таким как **стойкая потеря слуха, головокружение, паралич лицевого нерва, менингит или абсцесс мозга**.

Вы имеете право отказаться от рекомендованной процедуры, отложить её или получить мнение другого врача. Это решение никак не повлияет на любую другую медицинскую помощь, которая вам предоставляется. Вы можете отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры; однако, пожалуйста, имейте в виду, что после начала процедуры могут быть этапы, на которых её прекращение небезопасно с медицинской точки зрения.

6 Подготовка к процедуре

- Перед операцией проводится исследование слуха (аудиометрия), а при необходимости — компьютерная томография. Вас осмотрит анестезиолог.
- В течение **6–8 часов** до операции нельзя ничего есть и пить (пожалуйста, следуйте указаниям анестезиолога).
- Если из уха есть активные выделения, перед операцией вас могут попросить закапывать капли, чтобы подсушить ухо.
- В день операции волосы за ухом могут немного подстричь. При гриппе или инфекции дыхательных путей операция может быть отложена.
- Сообщите врачу обо **всех лекарствах**, которые вы принимаете (включая препараты, разжижающие кровь, аспирин, обезболивающие, средства для похудения и гормональные препараты), а также о любых **растительных средствах и добавках** (например, омега-3, витамин Е, гинкго, чеснок, женьшень, рыбий жир). Не прекращайте приём какого-либо лекарства самостоятельно, без согласования с врачом.
- Обязательно сообщите нам об **аллергиях**, проблемах с кровотечением или свёртываемостью крови, заболеваниях сердца и лёгких, диабете, нарушениях артериального давления или щитовидной железы, перенесённых операциях и любых проблемах, которые возникали у вас при анестезии.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Если есть вероятность, что вы беременны, или если вы кормите грудью, обязательно сообщите нам об этом до процедуры.
- Курение и никотиносодержащие продукты значительно ухудшают заживление ран. По возможности откажитесь от них как минимум за 2–4 недели до процедуры и не курите в период восстановления.

7 Восстановление: чего ожидать

Первые 24–48 часов	В ухе будут ощущаться распирание, лёгкая боль и заложенность; боль снимается обезболивающими. Возможны кратковременное лёгкое головокружение и тошнота. Давящую повязку обычно снимают на 1-й день. Не ложитесь на прооперированное ухо.
1–2-я неделя	Из-за губок в слуховом проходе в этот период слух будет казаться **сниженным**; это нормально. Возможны небольшие кровянистые выделения из уха. Швы обычно снимают **на 7–10-й день**. Большинство людей возвращаются к офисной работе в течение 1 недели.
3–6-я неделя	Губки из слухового прохода удаляются на контрольных осмотрах или рассасываются самостоятельно. В ухо ни в коем случае не должна попадать вода. Интенсивные физические нагрузки, подъём тяжестей и натуживание следует отложить примерно на **4–6 недель**. Перелёт обычно возможен **через 2–4 недели** с разрешения врача.
2–3-й месяц	На контрольных осмотрах оценивается, прижился ли трансплантат. Исследование слуха в этот период показывает, как операция повлияла на слух. Плавание и контакт уха с водой обычно разрешаются после одобрения врача.
6–12-й месяц	Барабанная перепонка и среднее ухо завершают заживление. После операции по поводу холестеатомы планируются регулярные осмотры и при необходимости визуализирующие исследования или повторная контрольная операция.

8 Возможные риски и осложнения

Как и любая медицинская процедура, эта процедура сопряжена с определёнными рисками. Ниже **ожидаемые временные эффекты** и **осложнения** приведены отдельно и сгруппированы по частоте их возникновения. Приведённые цифры — **приблизительные** значения, основанные на данных медицинской литературы; ваш личный риск может быть ниже или выше в зависимости от возраста, общего состояния здоровья, курения и перенесённых операций.

Подавляющее большинство осложнений **временные** и проходят при надлежащем лечении. В список включены и очень редкие, но серьёзные события; то, что они упомянуты, не означает, что они произойдут с вами, однако вам необходимо знать о них, чтобы принять осознанное решение.

Ожидаемые временные эффекты (не являются осложнениями — это естественная часть заживления)

- Ощущение распирания и заложенности в ухе, ощущение сниженного слуха в первые недели (из-за губок в слуховом проходе)
- Лёгкая боль в ухе, ощущение потрескивания, плеска воды или гула
- Небольшие кровянистые выделения из уха (первые дни)
- Временное онемение ушной раковины и области вокруг разреза; ушная раковина может немного оттопыриваться (после заушного доступа; это проходит в течение нескольких недель)

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Частые состояния (большинство из них временные или проходят при лечении)

- **Изменение вкуса** — Вкусовой нерв (барабанная струна) проходит сразу за барабанной перепонкой; во время операции он может растягиваться или в редких случаях его приходится пересекать. Примерно у **5–20 из 100** пациентов возникают металлический привкус, снижение вкуса на этой стороне языка или ощущение сухости во рту; обычно это **проходит или становится незаметным в течение от нескольких недель до нескольких месяцев**. В редких случаях это может сохраниться навсегда.
- **Шум в ухе** — После операции может появиться шум (звон) в ухе, или имевшийся шум может на время усилиться; обычно это временно.
- **Временное головокружение** — В первые дни возможны лёгкая неустойчивость или головокружение; обычно это проходит в течение нескольких дней.

Нечастые состояния

- **Неприживление трансплантата или новое отверстие** — Примерно у **5–15 из 100** пациентов барабанная перепонка может закрыться не полностью, или позднее может снова образоваться отверстие. В этом случае выделения из уха могут продолжаться, и **может потребоваться повторная операция**.
- **Слух не улучшается** — Даже если барабанная перепонка закрылась, слух может не улучшиться в ожидаемой степени из-за состояния слуховых косточек, вентиляции среднего уха или внутреннего уха. После восстановления слуховых косточек протез может сместиться или вытолкнуться через барабанную перепонку; может потребоваться дополнительная операция.
- **Инфекция уха и выделения** — После операции могут возникнуть выделения из уха или инфекция раны; обычно они проходят при лечении каплями или антибиотиками. Воспаление хряща ушной раковины (перихондрит) встречается редко, но может оставить деформацию хряща.
- **Сужение слухового прохода или латерализация барабанной перепонки** — Рубцовая ткань может сузить слуховой проход, или новая барабанная перепонка может сместиться от своего правильного положения; это может повлиять на слух и потребовать корректирующего вмешательства.
- **Рецидив или остаточная холестеатома** — После операции по поводу холестеатомы у части пациентов заболевание может вернуться или может разрастись небольшой остаток; поэтому необходимы длительное наблюдение и при необходимости **повторная операция**.
- **Проблемы с раной и рубцом** — Возможны утолщённый рубец или келоид в области заушного разреза, а в редких случаях — скопление жидкости за ухом.

Редкие или очень редкие, но потенциально серьёзные состояния

- **Стойкая потеря слуха вследствие повреждения внутреннего уха** — **Менее чем у 1 из 100** пациентов из-за поражения внутреннего уха может развиться **стойкая сенсоневральная тугоухость**; очень редко слух на оперированное ухо может быть полностью утрачен («мёртвое ухо»). Это может потребовать слухового аппарата или дальнейшей слуховой реабилитации. Риск выше при холестеатоме и заболеваниях, расположенных близко к внутреннему уху.
- **Длительное головокружение и нарушение равновесия** — В редких случаях из-за поражения внутреннего уха может возникнуть головокружение, длящееся неделями; могут потребоваться упражнения для тренировки равновесия и медикаментозное лечение.
- **Паралич лицевого нерва** — Поскольку лицевой нерв проходит через среднее ухо, очень редко (**значительно реже, чем у 1 из 100** пациентов) может развиться временная или стойкая слабость мышц лица на этой стороне. Риск выше при холестеатоме, повторных операциях и врождённо нетипичном ходе нерва. Если это произойдёт, может потребоваться медикаментозное лечение, защита глаза и при необходимости хирургическое вмешательство (декомпрессия или восстановление нерва). Если паралич окажется стойким, могут сохраниться асимметрия лица и неполное смыкание век; в этом случае потребуется длительная защита глаза и, возможно, операции по восстановлению мимики (реанимации лица).

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Осложнения со стороны оболочек мозга** — Особенно при мастоидэктомии и операциях по поводу холестеатомы, когда кость основания черепа истончена, очень редко могут возникнуть истечение спинномозговой жидкости (ликворея), менингит или повреждение мозговой оболочки. Это может потребовать дополнительного лечения в больнице (иногда в отделении интенсивной терапии) и операции; менингит в редких случаях может оставить стойкие последствия.
- **Стойкое изменение формы ушной раковины** — В результате заушного доступа или забора хрящевого трансплантата в редких случаях может навсегда сохраниться небольшое изменение положения или формы ушной раковины.

Общие риски, относящиеся к любому хирургическому / медицинскому вмешательству

- **Риски анестезии:** Если применяется общая анестезия или седация, её риски (тошнота, боль в горле, повреждение зубов, аллергическая реакция и, очень редко, проблемы с сердцем или лёгкими) отдельно разъяснит врач-анестезиолог, и ваше согласие будет получено на **отдельной форме согласия на анестезию**.
- **Кровотечение и переливание крови:** Необходимость переливания крови при этих процедурах возникает очень редко. При серьёзном кровотечении может потребоваться введение крови или препаратов крови; это также связано с собственными очень редкими рисками (например, аллергией или инфекцией).
- **Инфекция:** Раневую инфекцию после операции обычно лечат антибиотиками; в редких случаях может потребоваться дренирование (удаление гноя).
- **Тромбы в венах ног (ТГВ) и в лёгких (тромбоэмболия лёгочной артерии):** При непродолжительных операциях на голове и шее встречаются очень редко. Ранняя двигательная активность снижает риск. Приём гормональных препаратов, курение, ожирение и тромбозы в прошлом повышают риск.
- **Лекарственная аллергия:** Может развиться аллергическая реакция на используемые лекарства, антисептики, пластыри или шовный материал.
- **Рубцы и проблемы с заживлением:** Формирование рубцов у разных людей происходит по-разному; очень редко может образоваться грубый (гипертрофический) рубец или келоид.
- **Риск для жизни:** В наши дни смерть при плановых операциях на голове и шее встречается крайне редко; однако ни одно хирургическое вмешательство не является полностью безрисковым. При серьёзном осложнении может потребоваться лечение в отделении интенсивной терапии и может наступить стойкая инвалидность.

Этот список не охватывает все возможные осложнения; могут возникнуть и другие непредсказуемые и очень редкие события. Если разовьётся осложнение, врач спланирует необходимое лечение и наблюдение; это может потребовать дополнительного лечения, лекарств, процедур или повторной операции.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

9 Когда нужно немедленно связаться с нами

- **Внезапное выраженное снижение слуха** (резкое ухудшение, отличающееся от заложенности из-за губок)
- **Сильное головокружение**, рвота и невозможность стоять
- **Слабость мышц лица**: опущение уголка рта, невозможность закрыть глаз
- **Температура выше 38,5 °C**, нарастающая боль в ухе, покраснение и отёк ушной раковины или гнойные выделения с неприятным запахом
- **Прозрачные водянистые выделения** из уха, сильная головная боль или ригидность (напряжение) мышц шеи
- **Не прекращающееся кровотечение** из-под повязки или из уха

Если возникнет что-либо из перечисленного, немедленно позвоните своему врачу: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Если вы не можете с нами связаться, обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи или позвоните по номеру 112.

10 Рекомендации по лекарствам и повседневной жизни

- Пока врач не разрешит, **не допускайте попадания воды в ухо**: принимая душ, закрывайте ухо ватой, смазанной вазелином; не купайтесь в бассейне и море.
- В первые **4–6 недель не сморкайтесь**; если нужно чихнуть, чихайте с открытым ртом. Не зажимайте нос и не натуживайтесь (не выполняйте пробу Вальсальвы).
- В первые недели избегайте подъёма тяжестей, натуживания, наклонов и интенсивных физических нагрузок. Если у вас запор, сообщите об этом врачу.
- Перед перелётами, дайвингом и занятиями, связанными с перепадами давления, обязательно получите разрешение врача; для **дайвинга** обычно требуется более длительное ожидание.
- Не вводите в слуховой проход ватные палочки или какие-либо другие предметы; используйте назначенные ушные капли так, как вам показали.
- Если вы приехали из-за рубежа, планируйте обратную поездку вместе с врачом; контрольные осмотры и исследования слуха после возвращения можно продолжить у местного ЛОР-врача.
- Принимайте назначенные вам лекарства (антибиотики, обезболивающие и т. д.) в рекомендованной дозе и в течение рекомендованного срока. Не принимайте аспирин или подобные ему лекарства, которые могут усиливать кровоточивость, не посоветовавшись с врачом.
- Во время перелётов или поездок продолжительностью более 4 часов после операции пейте много воды, регулярно двигайтесь и, если вам это рекомендовано, носите компрессионные чулки; это снижает риск образования тромбов в ногах.
- В период восстановления рекомендуется не употреблять алкоголь, а также воздерживаться от курения и никотиносодержащих продуктов.
- Пожалуйста, обязательно приходите на все контрольные осмотры. Если вы приехали из-за рубежа, после возвращения домой наблюдение может продолжаться в формате онлайн-консультаций и по фото/видео; если вам понадобится обратиться к местному врачу, вам будут выданы письменный протокол операции и наши рекомендации.

11 Непредвиденные ситуации во время процедуры, образцы тканей и препараты крови

Если во время процедуры возникнет непредвиденная ситуация, врач останется в рамках той процедуры, на которую вы дали согласие в этой форме. **Если нет угрозы для жизни или риска серьёзного вреда для органа**, никакое дополнительное вмешательство, на которое вы не давали согласия, выполняться не будет; в таком случае процедура будет завершена в безопасный момент, а затем вас проинформируют, чтобы решение было принято вместе с вами. Если же ваша жизнь в опасности, будет оказана неотложная помощь, необходимая для сохранения вашей жизни или органа.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Удалённые во время процедуры ткани при необходимости направляются на **патоморфологическое (гистологическое) исследование** для уточнения диагноза. В зависимости от результата может потребоваться дополнительное лечение или наблюдение.

Переливание крови при этих процедурах требуется очень редко и проводится только по жизненным показаниям. Если вы не согласны на введение крови или препаратов крови (например, по религиозным убеждениям), обязательно сообщите об этом до процедуры; возможные последствия такого решения будут отдельно обсуждены с вами и записаны в разделе «Информация, касающаяся лично вас».

12 Фотографии, видеозаписи и ваши персональные данные

До и после процедуры могут быть сделаны **фотографии/видеозаписи** для планирования, наблюдения и оценки результата. Эти материалы являются частью вашей медицинской документации и хранятся конфиденциально. Ваши изображения **ни при каких обстоятельствах не будут использоваться для рекламы, продвижения или в социальных сетях.**

Использование ваших изображений для любых других целей возможно **только с вашего отдельного и явно выраженного разрешения**. Отказ никак не повлияет на ваше лечение, и вы можете отозвать своё разрешение в любое время:

- ☐ Я согласен(-на) на использование моих изображений **только для медицинской документации и наблюдения за лечением**.
- ☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, чтобы меня нельзя было узнать** (с закрытой областью лица/глаз).
- ☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, что меня можно будет узнать**.
- ☐ Я **не разрешаю** использование в научных/образовательных целях.

Ваши персональные данные и данные о здоровье обрабатываются в соответствии с турецким Законом о защите персональных данных № 6698 (KVKK) и соответствующим законодательством в сфере здравоохранения в целях диагностики, лечения и исполнения требований закона лицами, связанными обязательством сохранения профессиональной тайны. Подробную информацию вы найдёте в нашем Уведомлении о защите персональных данных.

13 Информация и примечания, касающиеся лично вас (заполняет врач)

Дополнительные риски, касающиеся данного пациента (сопутствующие заболевания, принимаемые лекарства, перенесённые операции), подробности плана, ожидания пациента, заданные вопросы и полученные ответы. Если добавить нечего, пишется «нет».

14 Заявление пациента

- ☐ Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму на своём языке. Мне было предоставлено достаточно времени для размышления; у меня была возможность задать вопросы, и я получил(-а) удовлетворившие меня ответы.
- ☐ Мне устно и письменно разъяснили моё состояние, цель рекомендованной процедуры, как, кем и где она будет выполнена, её примерную продолжительность, ожидаемую пользу, вероятность успеха, альтернативы и то, что может произойти, если её не проводить.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Мне разъяснили частые и потенциально серьёзные риски, а также возможные последствия этих осложнений (в том числе то, что может потребоваться дополнительное лечение или повторная процедура/операция). Я понимаю, что результат любой медицинской процедуры **не может быть гарантирован на 100%**.
- ☐ Я предоставил(-а) точную и полную информацию о своём здоровье, принимаемых лекарствах, аллергиях и перенесённых заболеваниях. Я понимаю, что неполная или неверная информация может увеличить риски.
- ☐ Я понимаю, что соблюдение указаний, данных до и после процедуры, влияет на результат и что посещение контрольных осмотров важно.
- ☐ Я знаю, что могу отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры. Я понимаю, что подписание этой формы не освобождает врача от обязанности проявлять должную заботу и тщательность.
- ☐ Я принимаю это решение по собственной воле, без давления с чьей-либо стороны.
- ☐ Я понимаю, что основная цель операции — закрыть барабанную перепонку и получить сухое, безопасное ухо; что улучшение слуха не может быть гарантировано и что в редких случаях слух может ухудшиться.
- ☐ Мне объяснили, что в зависимости от того, что будет обнаружено во время операции, может потребоваться восстановление слуховых косточек или мастоидэктомия, и я даю согласие на выполнение этих вмешательств так, как отмечено выше.

- ☐ **Я ДАЮ СВОЁ СОГЛАСИЕ на описанную выше процедуру.**
- ☐ **Я НЕ СОГЛАСЕН(-НА) на описанную выше процедуру. Мне разъяснили возможные последствия отказа.**

Рекомендуется, чтобы пациент написал собственноручно: «Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму и даю своё согласие».

15 Подписи

	ФАМИЛИЯ, ИМЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА / ВРЕМЯ
Пациент			
Законный представитель (родитель / опекун) — отношение к пациенту:			
Врач, предоставляющий информацию и выполняющий процедуру			
Переводчик (при необходимости) — язык:			
Свидетель (при необходимости)			

Заявление переводчика: я полностью и точно перевёл(-а) эту форму и устные разъяснения врача пациенту / законному представителю на понятный ему язык.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ ИЛИ С ОГРАНИЧЕННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ

За пациентов младше 18 лет согласие дают **родитель или законный опекун**. Ребёнка информируют в соответствии с его возрастом и зрелостью и учитывают его мнение. За недееспособных пациентов согласие даёт законный представитель.

☐ Если мы осуществляем родительские права совместно, я заявляю, что второй родитель осведомлён об этой процедуре и согласен с ней.

☐ Я заявляю, что не существует судебного решения или спора относительно опеки / попечительства (если они есть, соответствующий документ был предъявлен врачу).

Ребёнок проинформирован в соответствии с его возрастом; мнение ребёнка: _____

Эта форма составлена в двух экземплярах: один хранится в медицинской карте пациента, другой выдаётся пациенту / законному представителю.

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТЗЫВА СОГЛАСИЯ)

Я отзываю согласие, которое дал(-а) выше. Мне разъяснили возможные последствия отзыва согласия.

Ф. И. пациента/представителя, отзывающего согласие, подпись, дата и время: _____

Эта форма составлена в соответствии с Положением о правах пациентов Турецкой Республики и принципами информированного согласия Турецкой медицинской ассоциации. Она дополняет, но не заменяет устные разъяснения вашего врача.